Processo nº **0051442-31.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): MARTA GUIMARAES FERRARIO COELHO

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

**SENTENÇA**

Vistos etc.

Trata-se de **Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais**, ajuizada por MARTA GUIMARAES FERRARIO COELHO em face de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Na petição inicial (Id. 170360065), a Autora narra que é beneficiária do plano de saúde operado pela Ré e que, em fevereiro de 2024, foi diagnosticada com recidiva de neoplasia maligna de mama (CID C50.8), com metástase na glândula suprarrenal, cadeia linfonodal e lobo pulmonar. Alega que seu médico oncologista prescreveu tratamento quimioterápico com o medicamento Abemaciclibe 150mg, de uso contínuo e oral, associado ao Fulvestranto. Sustenta que, ao solicitar a autorização para o fornecimento do Abemaciclibe, a Ré negou a cobertura sob a justificativa de se tratar de medicamento para uso experimental e de exclusão contratual (Ids. 170363158 e 170363161). Argumenta que a recusa é indevida, pois o fármaco possui registro na ANVISA e sua indicação consta nas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ao final, formulou os seguintes pedidos: a concessão de tutela de urgência para que a Ré seja compelida a fornecer imediatamente o medicamento Abemaciclibe 150mg, sob pena de multa diária e, em caso de descumprimento, o bloqueio de valores suficientes para custear doze meses de tratamento, no montante de R$ 264.000,00; a confirmação da tutela em sentença; e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 22.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita e a prioridade na tramitação do feito.

A Ré foi devidamente citada em 15 de maio de 2024, conforme certidão do oficial de justiça (Id. 170602106).

Em sua contestação, apresentada tempestivamente em 05 de junho de 2024 (Id. 172565337), a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA arguiu, em sede preliminar, a impugnação ao valor da causa, requerendo sua redução para R$ 30.000,00, por entendê-lo mais condizente com a natureza da demanda. No mérito, defendeu a legalidade da recusa, sustentando que o medicamento Abemaciclibe, para o quadro clínico específico da Autora, caracteriza uso "off-label", ou seja, fora das indicações previstas em sua bula aprovada pela ANVISA, o que o equipara a tratamento experimental, expressamente excluído da cobertura contratual e do rol da ANS. Invocou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, que estabelece critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, defendendo sua aplicação análoga ao caso.

Alegou, ainda, a ausência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais e que a obrigação de garantir a saúde de forma irrestrita é um dever do Estado, não podendo ser transferida à operadora de saúde privada. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, a total improcedência dos pedidos da Autora. Subsidiariamente, pleiteou a produção de perícia técnica simplificada para averiguar a adequação do tratamento.

A parte Autora apresentou réplica à contestação (Ids. 172969407 e 189999775), rebatendo os argumentos da Ré, reforçando que o tratamento não é experimental e que a recusa é abusiva, além de impugnar os documentos juntados pela demandada.

Não houve audiência de conciliação, em razão do desinteresse manifestado pela parte Autora e do deferimento da tutela de urgência em caráter liminar (Id. 170403754).

Deferida a tutela de urgência (Id. 170403754), a Ré foi intimada para cumprir a decisão, mas permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (Id. 171076609 e 171537782). Diante do descumprimento, este Juízo determinou o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 282.000,00, para garantir o custeio de doze meses de tratamento, medida que foi efetivada com sucesso (Id. 171810484, 172269940 e 172269944). A partir de então, o tratamento da Autora passou a ser custeado por meio da expedição de alvarás mensais para a liberação de valores, permitindo a aquisição de cada caixa do medicamento (conforme despachos de Ids. 172731461, 175459174, 177892403, 180579155, 184065230 e 187377987). Somente em 19 de novembro de 2024, após meses de cumprimento forçado da medida, a Ré peticionou nos autos (Id. 188702302) informando que passaria a autorizar o fornecimento do medicamento e requerendo, por consequência, o desbloqueio do saldo remanescente.

É o Relatório. DECIDO.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pela parte Ré em sua contestação (Id. 172565337).

A primeira preliminar refere-se à impugnação ao valor da causa. A Ré sustenta que o montante de R$ 286.000,00, atribuído pela Autora, seria excessivo, e pugna por sua redução para R$ 30.000,00. Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou o de sua parte controvertida. No presente caso, a obrigação de fazer pleiteada possui conteúdo econômico claro e determinável, correspondente ao custo do tratamento negado. A Autora estimou o valor com base no custo médio mensal do medicamento (aproximadamente R$ 22.000,00) multiplicado por doze meses, critério que se mostra razoável e proporcional ao benefício econômico pretendido no período de um ano. A redução para o valor irrisório sugerido pela Ré esvaziaria o conteúdo econômico da demanda. Assim, rejeito a impugnação e mantenho o valor da causa originalmente atribuído.

A Ré também requereu, de forma subsidiária, a produção de perícia técnica simplificada. Tal pedido, contudo, mostra-se desnecessário para o deslinde da controvérsia. A questão central não reside em uma dúvida de natureza médica sobre a eficácia do tratamento, mas sim em uma controvérsia de natureza jurídica sobre a interpretação de cláusulas contratuais e a abrangência da cobertura do plano de saúde. Os documentos médicos carreados aos autos, em especial o laudo detalhado do médico assistente, Dr. Rossano Araújo (Id. 170362029), são claros, precisos e suficientes para comprovar a patologia da Autora e a pertinência da terapia prescrita. A realização de perícia, neste contexto, apenas retardaria indevidamente a prestação jurisdicional, em afronta ao princípio da celeridade processual, especialmente em um caso que envolve risco à vida. Portanto, indefiro o pedido de produção de prova pericial.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em verificar a legalidade da recusa da operadora de saúde em fornecer o medicamento Abemaciclibe 150mg, prescrito à Autora para tratamento de neoplasia maligna de mama metastática.

A materialidade da doença e a necessidade do tratamento estão robustamente comprovadas nos autos. O laudo médico (Id. 170362029), o resultado do exame PET SCAN (170363142) e o exame imunohistoquímico (Id. 170363146) formam um conjunto probatório coeso e inequívoco. Tais documentos atestam que a Autora é portadora de "Carcinoma invasivo de tipo não especial", com receptores de estrógeno positivos e HER-2 negativo, e que a doença progrediu para um quadro metastático, atingindo a glândula suprarrenal, linfonodos e pulmão.

Diante desse quadro clínico, o médico especialista que acompanha a paciente prescreveu, de forma fundamentada, o uso do medicamento Abemaciclibe, classificando-o como "protocolo de primeira linha" e destacando a urgência da medida, sob pena de "RISCO DE VIDA".

A Ré, por sua vez, fundamenta sua negativa (Ids. 170363161 e 172565349) na alegação de que o tratamento seria de "uso experimental". Para tanto, argumenta que o principal estudo clínico do medicamento (MONARCH-02) excluiu pacientes com metástases no Sistema Nervoso Central (SNC) e que, como os laudos da Autora não mencionam a ausência de tal condição, o caso se enquadraria como experimental.

Tal argumento é manifestamente improcedente e beira a má-fé. A justificativa da operadora se baseia em uma interpretação falaciosa e abusiva. Primeiramente, o fato de um estudo clínico excluir um determinado perfil de pacientes não torna o uso do medicamento experimental para todos os demais. A lógica é justamente a oposta: o estudo visa comprovar a eficácia para um grupo específico, e a indicação da bula reflete esse resultado. A Autora se enquadra perfeitamente na indicação principal do Abemaciclibe: câncer de mama avançado ou metastático, com receptor hormonal positivo e HER-2 negativo.

Em segundo lugar, a Ré tenta inverter o ônus da prova de forma indevida, exigindo que o laudo médico da Autora contenha uma informação negativa – a de que ela não possui metástase no SNC – para autorizar o tratamento. Ora, os exames apresentados, notadamente o PET SCAN (Id. 170363142), mapearam a extensão da doença e não apontaram qualquer lesão no sistema nervoso central. Exigir uma declaração expressa de ausência de uma condição que não foi diagnosticada é criar um obstáculo burocrático e desarrazoado para negar um direito legítimo. A ausência de menção a metástases no SNC nos laudos significa, para todos os fins, que elas não foram detectadas, e não que o quadro é uma incógnita que torna o tratamento "experimental".

O tratamento prescrito não é, de forma alguma, experimental. O medicamento Abemaciclibe possui registro válido na ANVISA e sua utilização para o quadro clínico da Autora está em conformidade com as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e com a prática oncológica corrente, conforme atestado pelo médico especialista. A recusa da operadora, portanto, representa uma interferência indevida na autonomia do profissional de saúde, a quem compete, com exclusividade, definir a terapia mais adequada para seu paciente.

A relação entre as partes é de consumo, e, como tal, deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas contratuais que restringem direitos e colocam o consumidor em desvantagem exagerada são consideradas nulas de pleno direito. A cláusula que exclui a cobertura de tratamentos "experimentais" não pode ser interpretada de forma a abarcar medicamentos devidamente registrados e prescritos pelo médico para doença coberta pelo plano. Tal interpretação esvaziaria o próprio objeto do contrato, que é a garantia da saúde do beneficiário.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, havendo cobertura para a patologia, é abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico, ainda que não conste expressamente no rol da ANS, cuja natureza é de cobertura mínima obrigatória (taxatividade mitigada). No caso em tela, a situação é ainda mais favorável à Autora, pois o medicamento está expressamente indicado para a sua condição. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA SEÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO EX NUNC. NEOPLASIA MALIGNA. EXAME DE PET-SCAN. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS. EFEITO IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO. 2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886 .929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. A Lei nº 14.454/2022 promoveu alteração na Lei nº 9.656/1998 (art. 10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar . 4. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo. 5 . A superveniência do novo diploma legal (Lei nº 14.454/2022) foi capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer uma "interpretação autêntica", ressalta-se que o sentido colimado não vigora desde a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos ex nunc, já que a nova regra modificadora ostenta caráter inovador. 6 . Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. 7. Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a sua aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato sucessivo. Assim, nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela Lei nº 14.454/2022, diante da aplicabilidade imediata da lei nova. Aplicação também do Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde, ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 8. Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a interpretação da legislação da época, devendo incidir aos casos regidos pelas normas que vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de sua vigência, aos fatos daí sucedidos. 9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências. 10. Na hipótese, aplicando-se os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei nº 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de realização do PET-SCAN (ou PET-CT), ainda mais em se tratando de exame vinculado a tratamento de câncer. 11. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2057897 SP 2023/0077970-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2024)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Configurada a abusividade da conduta da Ré, resta analisar o pedido de indenização por danos morais. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial, especialmente em se tratando de doença grave e de evolução rápida como o câncer, não constitui mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual. A negativa da operadora impôs à Autora, pessoa idosa e já fragilizada pela doença, uma angústia e um sofrimento que extrapolam o dissabor cotidiano. A incerteza quanto ao início de um tratamento vital, a necessidade de buscar o Poder Judiciário para ter seu direito assegurado e o temor de uma progressão irreversível da doença configuram, sem sombra de dúvida, dano moral, que, em casos como este, é presumido (*in re ipsa*).

No que tange ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter dúplice da reparação: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo à ofensora, de modo a desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

**DISPOSITIVO**

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

**1. Tornar definitiva a tutela de urgência concedida, para condenar a Ré, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, na obrigação de fazer consistente em fornecer à Autora, MARTA GUIMARAES FERRARIO COELHO, o medicamento ABEMACICLIBE 150 mg, na quantidade e periodicidade prescritas por seu médico assistente, enquanto perdurar a necessidade do tratamento para a patologia que a acomete.**

**2. Condenar a Ré, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, a pagar à Autora, MARTA GUIMARAES FERRARIO COELHO, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, a ser corrigido monetariamente pela tabela ENCOGE a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da negativa indevida (09/05/2024), até o dia 27/08/2024; a partir do dia 28/08/2024, atualização pela taxa Selic.

Condeno a parte Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (danos morais somados a doze meses do custo do tratamento), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte Autora, a exigibilidade das verbas de sucumbência que lhe caberiam, caso vencida, observaria o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ressalto a incidência dos Enunciados nºs 23 e 27 da I Jornada de Direito Privado e Processual Civil dos Magistrados de 1º Grau do TJPE:

23º) Os embargos de declaração devem indicar especificamente o ponto inicial da decisão judicial que contenha erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, demonstrando sua correlação com os pedidos formulados pela parte embargante. A oposição genérica do recurso ou com intuito de rediscutir teses já apreciadas, sem apontar objetivamente o vício embargável, caracteriza intuito protelatório passível de multa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

27º) Com a promulgação da Lei 14.905/2024, que alterou o Código Civil (CC) em relação a juros e atualização monetária, adotar-se-á, nas ações propostas antes da vigência da mencionada lei, regra mista, com a utilização da Tabela do Encoge, e juros de 1% ao mês até o dia 27/08/2024 e, a partir do dia 28/08/2024 a taxa Selic, com a fixação da atualização monetária através do IPCA e os juros através da taxa Selic menos o IPCA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife/PE, data da assinatura digital.

Danilo Félix Azevedo

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: DANILO FELIX AZEVEDO
06/11/2025 14:33:50
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 222050931

25110614335075800000216088358

IMPRIMIR GERAR PDF